Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012639-19.2023.8.21.0027/RS

AUTOR: ALINE GRUNDLING GIULIANI

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

ALINE GRUNDLING GIULIANI ajuizou "*ação ordinária com pedido de antecipação de tutela*" em desfavor da **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.** alegando ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré, de cobertura com abrangência nacional. Disse que foi diagnosticada com esclerose múltipla (CID - 10: G35) e que está em tratamento desde o ano de 2017. Ressaltou que, recentemente, houve alteração em seu quadro médico, sendo constatado, após a realização de exames, a atividade da doença com aumento importante da carga lesional. Sustentou que o médico-assistente indicou, para o caso, o medicamento Mavenclad (cladribina oral), pois único adequado para o seu caso, especialmente em razão de estar amamentando a sua filha recém-nascida. Teceu considerações acerca do direito à saúde e postulou a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que forneça o medicamento CLADRIBINA (Mavenclad) 10mg na quantidade prescrita pelo médico.

Deferido o parcelamento das custas processuais em oito vezes (evento 8). Na oportunidade, foi **concedida a tutela provisória** para determinar à ré que disponibilize o medicamento CLADRIBINA (Mavenclad) 10mg à autora, conforme tratamento indicado por seu médico assistente, no prazo de 72h, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 2.000,00, desde já limitada ao período de trinta dias.

Citada (evento 19), a parte ré apresentou **contestação** (evento 22). Em sede de preliminar, impugnou o valor da causa, sob o argumento que a autora indicou como valor da causa a quantia de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), sem demonstrar como chegou a tal montante. Assim, pediu que fosse corrigido o valor da causa para o valor de alçada. No mérito, alegou ausência de cobertura do medicamento domiciliar indicado pelo médico assistente, ressaltando, neste ponto, a legitimidade da negativa da cobertura. Assinalou que a demandante é beneficiária de plano de assistência à saúde de cunho coletivo por adesão firmado com a Unimed Porto Alegre desde 01/01/2014. Referiu que o quadro clínico da autora não comporta a concessão de medicamento para uso domiciliar, uma vez que não se trata de medicação para tratamento de câncer, nem de internação domiciliar. Destacou que não se discute a eficácia do medicamento para o tratamento da autora, mas a sua cobertura. Disse que é incabível a inversão do ônus da prova. Pediu a improcedência da ação.

Houve **réplica** (evento 25). A parte autora requereu a rejeição da impugnação ao valor da causa, esclarecendo ter sido fixado com base no orçamento de 28 (vinte e oito) comprimidos, que totalizava R$ 422.364,40 (quatrocentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). No mérito, alegou que a lista da ANS não é taxativa. Referiu que sua doença é comparada a câncer, com alta carga lesional, que, caso não tratada, pode deixar sequelas graves. Juntou orçamento do medicamento (evento 25, doc 1).

As partes pediram o julgamento antecipado da lide (eventos 32 e 33).

A parte peticionou, informando que a parte ré não cumpriu integralmente a tutela de urgência deferida (evento 35). Assim, pleiteou a intimação da parte demandada para fornecer 14 compridos do medicamento CLADRIBINA (Mavenclad) 10mg. Ademais, frente ao não cumprimento da medida liminar, pediu a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de astreintes.

A parte ré alegou cumprimento integral da tutela provisória ao fundamento que a entrega dos 14 comprimidos restantes deve ser realizada um ano após o primeiro ciclo, nos termos do laudo médico.

A autora peticionou, assinalando que os 28 compridos deveriam ser disponibilizados juntos, independente da data de uso. Pontuou, nesta senda, estar pendente o cumprimento da tutela provisória.

Reconhecido o cumprimento integral da tutela, nos termos do laudo médico juntado. Ademais, foi retificado o valor da causa para R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

A parte autora peticionou, requerendo a disponibilização dos 14 comprimidos (evento 75).

Deferido o pedido da demandante (evento 77).

A parte ré comprovou o cumprimento da tutela de urgência (82.1).

Juntada certidão (evento 86).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estando o feito estreme de vícios formais e não havendo interesse das partes na abertura da instrução, passo, de pronto, à análise do mérito, revisando, inicialmente, os fatos alegados e as provas juntadas aos autos.

DO MÉRITO

A parte autora pleiteia a condenação da parte ré à cominação da obrigação de fazer consistente em fornecer o medicamento CLADRIBINA (Mavenclad) 10mg, na dosagem indicada por seu médico assistente.

Conforme narra a inicial, a parte autora é portadora de esclerose múltipla forma remitente-recorrente e apresenta "*9 lesões encefálicas e lesão captante ao contraste na medula cervical*". O médico assistente Dr. DOUGLAS KAZUTOSHI SATO destacou que, em razão de ALINE estar em período de amamentação de sua filha, o medicamento indicado para o tratamento da doença é o CLADRIBINA oral (MAVENCLAD®).

Para provar os fatos expostos, juntou carteira de beneficiário (1.4), laudo de ressonância magnética de encéfalo (1.5, 1.6, 1.7, 1.8), atestado médico (1.9), certidão nascimento da filha da parte autora (1.10), receituário médico (1.11), protocolo administrativo (1.12), formalização da negativa (1.13), bula do medicamento (1.14) e orçamento (25.2).

A negativa da cobertura do medicamento Mavenclad (CLADRIBINA) 10mg à autora é incontroversa, nos seguintes termos (evento 1, DOC13):

> *No tocante a solicitação do medicamento Mavenclad (CLADRIBINA), não restou atendida a diretriz de utilização especificadas no Rol de coberturas obrigatórias dispostas nas Instruções Normativas 65.13 da Resolução Normativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e, ainda, conforme Art. 17, § 1º, inciso VI e Art. 18 IX e X, da Resolução Normativa n.º 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Considerando que a Lei 9656/98 Art. 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g, deixa explícito que apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásicos oral e/ou venoso constantes no Rol vigente haverá cobertura, sendo assim não cabe análise de excepcionalidade disposta Art. 10 § 12 e 13 da Lei 9.656/98, não cabendo a avaliação de excepcionalidade prevista na Lei 14.454/22.*

Na justificativa apresentada pela ré, em sede de contestação, há menção de que o medicamento não está no previsto no rol da ANS, bem como há a exclusão de cobertura do medicamento, ora pleiteado pela autora, em razão de não ser destinado para o tratamento de câncer ou internação domiciliar, nos termos do artigo 10, VI, da Lei n.º 9.656/1998. A fim de corroborar suas alegações, juntou o contrato de assistência à saúde plano coletivo por adesão plano UNIPART global (22.2), aditamento contratual (22.3), declaração (22.4), parecer (22.5), folha de prescrição médica (35.2 e 43.2) e protocolo de solicitação (82.2).

A controvérsia reside em saber se há obrigação da operadora do plano de saúde fornecer o medicamento indicado para o tratamento da demandante ou não.

Pois bem.

Quanto à taxatividade do rol da ANS, a questão foi alvo de polêmica judicial e legislativa, sendo que o Superior Tribunal de Justiça determinou, num primeiro momento, que o rol da ANS era taxativo, em regra (EREsp 1886929/SP). Após o julgamento realizado pelo STJ, sobreveio a Lei n.º 14.454/2022, alterando dispositivos da Lei n.º 9.656/1998, para assentar que o rol da ANS constitui **referência básica** para o fornecimento dos tratamentos pleiteados às operadoras de planos de saúde (artigo 10, § 12º, da Lei n.º 9.656/1998).

Sobre o tema, o Tribunal do Rio Grande do Sul apresenta entendimento de que o rol apresentado pela ANS não é taxativo, podendo ser excepcionado quando há prescrição médica fundamentada e evidências científicas da eficácia do tratamento:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE MITRACLIP PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA MÉDICA E PRESCRIÇÃO CLÍNICA FUNDAMENTADA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. RECUSA ABUSIVA. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO AO CDC, QUE IMPÕE A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE NOS CASOS DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS OU OMISSAS (CDC, ART. 47).* ***A LEI N. 14.454/2022 CONFERIU NATUREZA EXEMPLIFICATIVA AO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS, EXIGINDO COBERTURA DE TRATAMENTOS NÃO LISTADOS QUANDO HOUVER PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA COM RESPALDO TÉCNICO OU CIENTÍFICO.*** *ALÉM DISSO, O ART. 35-C DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE IMPÕE O DEVER DE COBERTURA NOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SENDO SUFICIENTE A INDICAÇÃO MÉDICA QUE ATESTE RISCO IMEDIATO À VIDA OU LESÕES IRREPARÁVEIS. IN CASU, O PROCEDIMENTO DE REPARO DA VÁLVULA MITRAL POR MITRACLIP FOI EXPRESSAMENTE RECOMENDADO EM RAZÃO DO ELEVADO RISCO DA CIRURGIA CONVENCIONAL, CONFORME LAUDOS MÉDICOS E PARECER TÉCNICO DO NATJUS, DEMONSTRANDO URGÊNCIA E EFICÁCIA CLÍNICA. A RECUSA DE COBERTURA, DIANTE DA URGÊNCIA E DA INDICAÇÃO CLÍNICA, VIOLA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (CC, ART. 421) E O DIREITO À SAÚDE E À VIDA (CF, ART. 196), REVELANDO CONDUTA ABUSIVA E INJUSTIFICADA DA OPERADORA. A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CÂMARA CÍVEL RECONHECE O DEVER DAS OPERADORAS DE CUSTEAR TRATAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO ASSISTENTE, MESMO QUANDO NÃO PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO ROL DA ANS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS CRITÉRIOS LEGAIS DE EFICÁCIA E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 51642913020248210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 30-04-2025)*
>
> *[destaquei]*

No caso concreto, a discussão não é relacionada à eficácia do tratamento para a doença que acomete a autora, mas sim à exclusão da cobertura, por ser de uso domiciliar.

Em relação à exclusão da cobertura para medicamentos de uso domiciliar, o artigo 10, VI, da Lei n.º 9.656/1998, estabelece que, com exceção do disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12, estão **excluídos da cobertura assistencial** o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Neste ponto, transcrevo os referidos artigos:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**:*
>
> *[...]*
>
> *VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12**;*
>
> *[...]*
>
> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *[...]*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *[...]*
>
> *g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;*
>
> *[...]*

Do que se depreende do dispositivo legal, a operadora de planos de saúde não é obrigada, como regra, a fornecer o medicamento de uso domiciliar para o tratamento da doença que acomete a autora.

Ocorre que os fatos narrados na inicial envolvem situação excepcional.

Conforme já mencionado na decisão que concedeu a tutela de urgência - não impugnada, aliás -, o atestado médico juntado pela autora (evento 1.9) evidencia que esta convive com a doença desde o ano de 2017, momento em que iniciou o tratamento, passando por diversos medicamentos. Em 2022, a autora vivenciou uma gestação sem complicações, com parto no mês de dezembro (evento 1.10), iniciando o aleitamento materno. Há menção, no entanto, de que, no início de 2023, *iniciou um quadro vertiginoso não rotatório, que durou alguns dias, sugestivo de um surto da doença*, situação em que o médico atestou ser indicado tratamento de alta eficácia como "*natalizumabe, ocrelizumabe, alemtuzumabe ou cladribina oral*".

Especificamente quanto aos medicamentos, o médico esclareceu que os três primeiros citados não são indicados para quem está amamentando, afirmando que a cladribina oral é a mais adequada ao caso, pois *a paciente pode interromper a amamentação somente nos 5 dias de tratamento e nos 7 dias subsequentes,* o que *permite o tratamento com medicamento de alta eficácia ao mesmo tempo que permite continuar com a amamentação com leite materno que garante aspectos nutricionais e psicossociais da paciente e de sua filha.*

Vê-se, por conseguinte, que a indicação do medicamento de uso oral (domiciliar) no caso em análise é excepcional, **em substituição às demais possibilidades, não indicadas para lactantes, que seriam regularmente cobertas pelo plano**, eis que administrados por infusão intravenosa - conforme informações de suas bulas[1].

Vale ressaltar que a bula do medicamento Clabidina oral (MAVENCLAD®) (evento 1.14), é clara ao indicá-lo para o tratamento de **pacientes adultos com esclerose múltipla recorrente altamente ativa, sendo evidenciada a sua eficácia no atraso da progressão da incapacidade e na diminuição de lesões ativas medidas por ressonância**.

No caso concreto, portanto, mostra-se irrelevante o fato de se tratar de medicação para uso domiciliar, vez que a utilização foi feita sob específica orientação médica, inclusive com período determinado (dois ciclos - 2022/2023 e 2023/2024), e o procedimento apresenta inclusive um custo **menor** para o plano de saúde, que não precisa despender com o pagamento de profissional e local específico para aplicação. Desse modo, não se sustenta a alegação genérica de que o fornecimento do fármaco em questão implicaria o desequilíbrio atuarial do plano.

Ademais, é sabido que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes sendo permitido limitar o tipo de tratamento prescrito, incumbência de competência exclusiva do profissional médico que assiste o paciente. Nesse sentido, aliás, o entendimento jurisprudencial:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA MEDICAMENTO MAVENCLAD CLADRIBINA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. I. DE ACORDO COM A REDAÇÃO DO ART. 300, CAPUT, DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA MOSTRA-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS: A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. II. E, **NO CASO CONCRETO, A***

AUTORA É PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, BEM COMO QUE, EM RAZÃO DA GESTAÇÃO, É INDICADO O TRATAMENTO COM O FÁRMACO MAVENCLAD CLADRIBINA - 10 MG. *ALÉM DISSO, EM QUE PESE INAPLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO, DEVEM SER OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL, PREVISTOS NOS ARTS. 421 E 422, DO CÓDIGO CIVIL. INCLUSIVE, NOS TERMOS DO ART. 423, DO CÓDIGO CIVIL, NOS CONTRATOS DE ADESÃO, DEVE SER ADOTADA A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE, QUANDO VERIFICADAS CLÁUSULAS AMBÍGUAS OU CONTRADITÓRIAS. III. DA MESMA FORMA, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, AINDA QUE NÃO HAJA PREVISÃO EM ROL DA ANS. IMPORTANTE DESTACAR, NESTE PARTICULAR, QUE O JULGAMENTO PELO EGRÉGIO STJ ACERCA DA TAXATIVIDADE DO REFERIDO ROL AINDA NÃO CONTA COM O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50580574720228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 31-08-2022)*

Necessário observar que a operadora demandada não demonstrou que, à época da prescrição do medicamento, existia outro procedimento **eficaz, efetivo e seguro para as condições específicas da parte autora**, limitando-se a defender a impossibilidade de custeio em razão do uso domiciliar.

Assim, com base na interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor), em observância ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana e à proteção especial conferida à família (art. 226 da Constituição Federal) e à criança (art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente), imperiosa a procedência da ação para confirmar a tutela de urgência inicialmente concedida, para manter a cobertura relativa ao medicamento utilizado pela autora durante o período da amamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por ALINE GRUNDLING GIULIANI contra UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA para, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, confirmar a tutela de urgência concedida nos eventos 8.1 e 77.1, consolidando a obrigação de fazer cominada em desfavor da ré, para custear o tratamento da autora por meio do uso do medicamento CLADRIBINA (Mavenclad), na forma indicada pelo seu médico-assistente.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor retificado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Sentença publicada pelo lançamento de documento digital no sistema **eproc**. Desnecessário o registro. Intimem-se. **Caso haja revel**, PUBLIQUE-SE no Diário de Justiça Eletrônico, em atenção ao artigo 346, *caput*, do Código de Processo Civil.

Sobrevindo recurso(s) de **embargos de declaração**, dê-se vista à parte oposta, por cinco dias. Depois, voltem para análise.

Interposto(s) **recurso(s) de apelação**, dê-se vista à(s) parte(s) apelada(s) para, em quinze dias, apresentar(em) contrarrazões. Caso haja recurso adesivo ou suscitação de questões preliminares (artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil) em contrarrazões, dê-se vista ao(s) apelante(s) por novos quinze dias, para manifestação. Concluídas as intimações e decorridos os prazos, remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça.

Com o **trânsito em julgado**, certifique-se pelo lançamento do correspondente movimento no sistema **eproc**. Após, nada mais sendo requerido, e não subsistindo pendências, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **TRAUDELI IUNG, Juíza de Direito**, em 28/06/2025, às 16:55:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10082914370v59** e o código CRC **b62d543f**.

---

1. https://consultaremedios.com.br/natalizumabe/bula?srsltid=AfmBOooLyiBdaPpB5d8PuemD6sOKm1b0Ncs--C__pa5OjUjtSDs-y1rXhttps://consultaremedios.com.br/ocrevus/bula?srsltid=AfmBOooOanh-xy2D4Ub2raezCrO_kpzaUF_FOk4s70s2vCiz5uyGK25nhttps://consultaremedios.com.br/alentuzumabe/bula?srsltid=AfmBOoohFKcHeSyqv3Jsm7TyQ9MAWi33PNiA2rucbyXDrQJhOb3Z_TaZ ↩